

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN POST PARTUM DENGAN PEB/EKLAMPSIA		
	No. Dokumen 571.19/I- SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Perawatan pada wanita yang baru melahirkan dengan gejala - gejala hipertensi (tensi ≥ 160 mmHg), proteinuria (albumin urine +2) ,oedema dan atau disertai kejang ataupun koma		
Tujuan	1. Sebagai acuan penerapan tindakan perawatan penderita post partum dengan PEB/Eklampsia mulai persiapan alat sampai dengan evaluasi dan dokumentasi 2. Meniminimalkan komplikasi akibat PEB/Eklampsia 3. Agar tindakan yang dilakukan berjalan efektif, efisien, konsisten dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standart yang berlaku		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan Bidan.		
Prosedur	1. Siapkan alat 1.1. Siapkan alat-alat: 1. Tensimeter 2. Stetoscope 3. Hammer 4. Jam tangan 5. Obat-obatan sesuai terapi 6. Botol untuk pemeriksaan UL 1.2. Dekatkan alat disamping pasien 2. Siapkan pasien 1. Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2. Perkenalkan diri pada pasien 3. Identifikasi pasien (nama , register , tanggal lahir) 4. Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 5. Atur pasien dalam posisi yang dirasakan nyaman untuk pasien 3. Siapkan lingkungan 3.1 Tempatkan pasien di ruangan yang tenang, nyaman dan <i>privacy</i> terjaga 4. Lakukan tindakan perawatan pada pasien post partum PEB/Eklampsia 1. Cuci tangan 6 langkah		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PERAWATAN POST PARTUM DENGAN PEB/EKLAMPSIA		
	No. Dokumen 571.19/I- SPO/MTR/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
Prosedur	2. Beri O2 2 - 4 l/mnt 3. Observasi keadaan umum meliputi : a. TTV (tensi, nadi, RR , reflek patella, ronchi) b. Keluhan subjektif, tanda impending eklampsia (pusing, mata kabur, mual muntah dan nyeri ulu hati. c. Kontraksi uterus, perdarahan pervaginam, keadaan luka perineum. 4. Periksa UL secara berkala untuk evaluasi. 5. Lakukan personal hygiene (diseka 2 kali sehari dan <i>vulva hygiene</i>) 6. Berikan terapi sesuai instruksi dokter : a. <i>Sulfas magnesikus</i> maintenance dengan dosis SM 40 % 5 gram secara intra muskuler atau drip dalam cairan infuse RD5% 500cc tiap 6 jam sampai dengan 24 jam post partum bila kontra indikasi pemberian SM negative b. Antibiotik. c. Analgetik. d. Antihipertensi (bila tekanan diastolik > 160 mmHg) e. Diuritik bila ada oedema paru, payah jantung atau oedema anasarka. f. Roboransia. 7. Diit protein 1-1,5 gr/kg BB/hari bila ada uremia diberikan 0,6 gr/kg BB / hari dan tinggi kalori. 8. Mobilisasi bertahap. 9. Penderita boleh pulang bila : a. Albumin urine negative atau positif 1 b. Tensi kurang dari 160/110 mmHg c. Keadaan umum baik 5. Rapikan pasien dan bereskan alat 1. Rapikan pasien dengan posisi yang nyaman 2. Bereskan alat-alat 3. Cuci tangan 6 langkah 6. Lakukan evaluasi dan dokumentasi perkembangan pasien 1. Beritahu ibu setiap tindakan sudah selesai dilakukan 2. Jelaskan bahwa ibu masih perlu pemantauan hingga 24 jam setelah melahirkan di kamar bersalin dan dilanjutkan pemantauan rutin di ruangan nifas patologis 3. Catat kondisi ibu dan buat laporan tindakan		
Unit Terkait	1. IGD 2. Ruang Kandungan & Kebidanan		